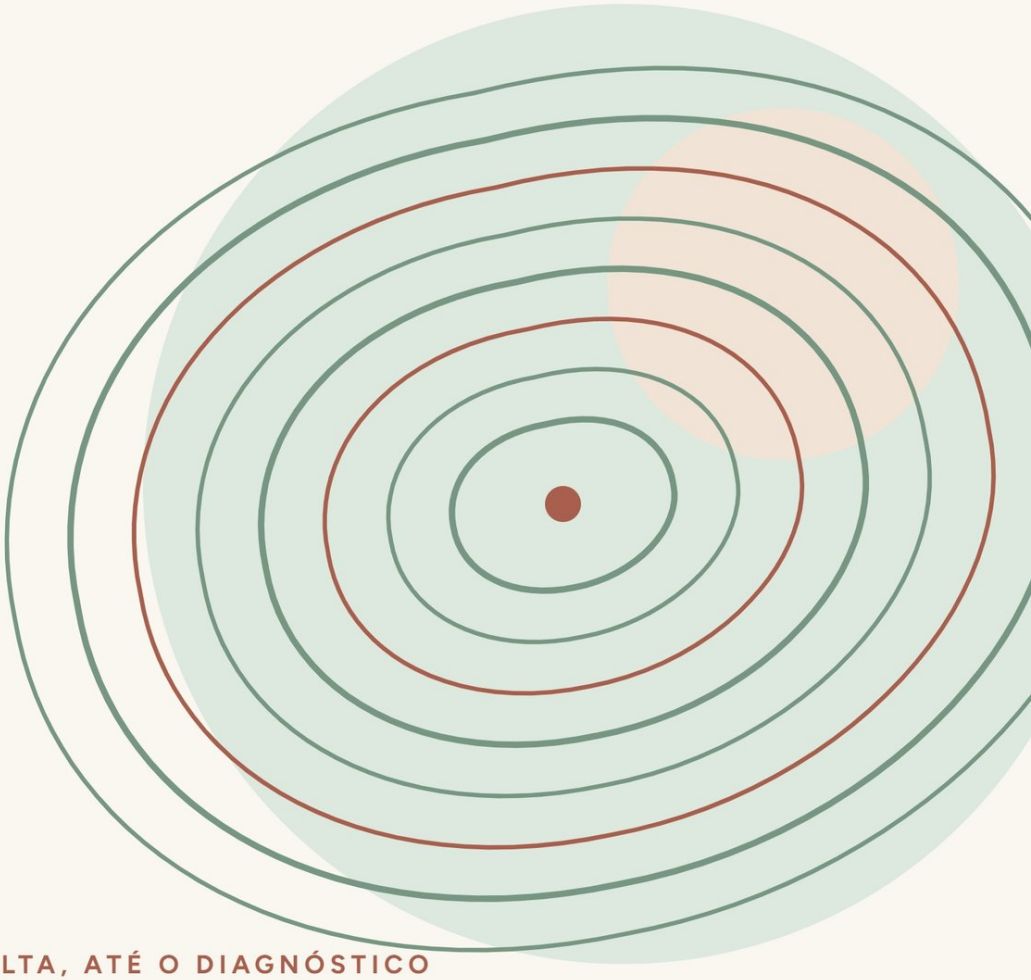
SAÚDE MENTAL · GUIA + 3 FOLHAS

@usedraxora



PARA A PRIMEIRA CONSULTA, ATÉ O DIAGNÓSTICO

Mapa dos *Sintomas*

Leia para entender os três quadros e saber o que contar.
Use as folhas para registrar e levar tudo a cada consulta.

Bipolar Tipo 1 | Bipolar Tipo 2 | Borderline | TDAH

DRAXORA

20s por dia para registrar, só pintando

3 folhas essenciais para imprimir

1 página pronta para cada consulta

COMECE AQUI

3 passos. Sem precisar ler nada antes.

O guia fica para quando você estiver bem. Para começar, só isto:

1

Preencha a “Ficha da primeira consulta” p. 22

Uma vez, uns 5 minutos: sua história em uma página. Imprima as folhas (p. 20 a 23) e deixe a “Minha semana” ao lado da cama.

2

Pinte 2 bolinhas por dia na “Minha semana” 20 segundos

Uma no sono e uma no humor. Dia difícil? Pinte só o humor ou deixe em branco: um dia em branco também diz algo.

3

Na véspera, preencha “Para levar à consulta” p. 21

Junte as semanas em uma página e entregue ao profissional. Repita a cada consulta, até o diagnóstico.

Alguém pode fazer por você

Se estiver difícil, quem convive com você pode pintar as bolinhas e levar a folha.

Em crise, não preencha nada

Peça ajuda: CVV **188** (24 h, gratuito) ou SAMU **192**.

ESSENCIAL

3 folhas

Ficha da primeira consulta, Minha semana e Para levar à consulta. É tudo de que você precisa.

EXTRAS

1 folha + o guia

“O que estou sentindo”, quando algo acontecer. As folhas para imprimir estão nas páginas 20 a 23.

ANTES DE COMEÇAR

Leia isto primeiro

Este guia é educativo. Ele não faz diagnóstico e não substitui a avaliação de um psiquiatra ou psicólogo. O objetivo é um só: ajudar você a observar o que sente e contar isso ao profissional com clareza. O guia é uma ponte entre você e quem cuida de você.

O que este guia é

Um mapa para observar e registrar o que você sente, e levar isso organizado para a consulta.

O que ele não é

Não é diagnóstico e não substitui a avaliação de um psiquiatra ou psicólogo.

O que não fazer

Não use o material para se rotular, nem para começar, parar ou mudar medicação por conta própria.

Para quem é este guia

Para quem convive com sintomas de bipolaridade, borderline ou TDAH. Ele serve para o caminho até o diagnóstico:

Ainda sem diagnóstico

Para a primeira consulta

Você se reconhece em sintomas como mudanças de humor, impulsividade ou falta de foco e vai à primeira avaliação.

Até o diagnóstico

Para cada consulta

Às vezes o diagnóstico leva mais de uma consulta. Use as folhas em quantas precisar.

SE PRECISAR DE AJUDA AGORA

Se você está pensando em se machucar ou em tirar a própria vida, procure ajuda agora.

Ligue para o CVV ou acesse cvv.org.br. Em emergência, ligue para o SAMU ou vá ao pronto-socorro mais próximo.

188
CVV · gratuito, 24h

192
SAMU · emergência

SUMÁRIO · COMECE PELA PÁGINA 02

O que você vai encontrar

LEIA O guia

ii **Introdução: por que o diagnóstico pode levar tempo** 05

01 **Transtorno Bipolar tipos 1 e 2** 06
Mania, hipomania e depressão · O que anotar sobre cada fase

02 **Transtorno de Personalidade Borderline** 09
Padrões mais comuns · Por que se confunde com o Bipolar

03 **TDAH em adultos** 12
Desatenção · Hiperatividade e impulsividade

04 **Detalhes que vale a pena observar** 15
O que anotar · Fatos, não rótulos

05 **Como relatar ao psiquiatra** 17
A fórmula do relato preciso · Dicas para a consulta

USE As folhas para imprimir

→ **Essenciais e extra** 19
Qual folha usar e quando

20s **Minha semana** ESSENCIAL 20
Todo dia · sono e humor

5m **Para levar à consulta** ESSENCIAL 21
Na véspera de cada consulta · tudo em uma página

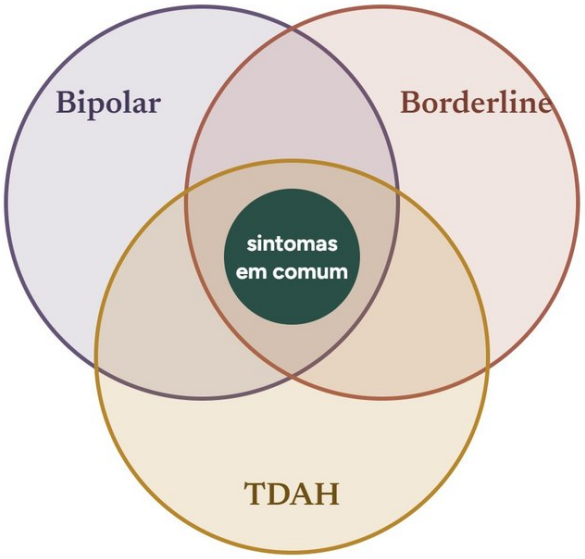
1x **Ficha da primeira consulta** ESSENCIAL 22
1 vez · sua história em uma página

1m **O que estou sentindo** EXTRA 23
Quando acontecer · uma linha

Depois do diagnóstico · p. 24 · Fechamento, onde buscar ajuda e referências · p. 25

INTRODUÇÃO

Por que o diagnóstico pode levar tempo



Transtorno Bipolar, Borderline e TDAH compartilham sintomas na superfície. Por isso, chegar ao diagnóstico certo às vezes leva tempo e mais de uma consulta.

- Impulsividade
- Mudanças de humor
- Irritabilidade
- Dificuldade de concentração
- Relações instáveis

O problema raramente é falta de sintomas. Quase sempre é a forma como eles chegam ao consultório. Na hora da consulta, é difícil lembrar tudo o que aconteceu e encontrar as palavras certas.

> **Meu humor oscila muito.**
>
> Frases assim servem para os três quadros e dizem pouco sobre o que você está vivendo.

4 detalhes que vale a pena observar

Você não precisa interpretar nada, só observar e anotar. O capítulo 4 mostra como.

Duração

Quanto tempo cada estado dura: horas, dias ou semanas.

Gatilho

O que provoca a mudança: algo que aconteceu ou nada aparente.

Início

Desde quando você é assim: desde a infância ou a partir de certa idade.

Entre as crises

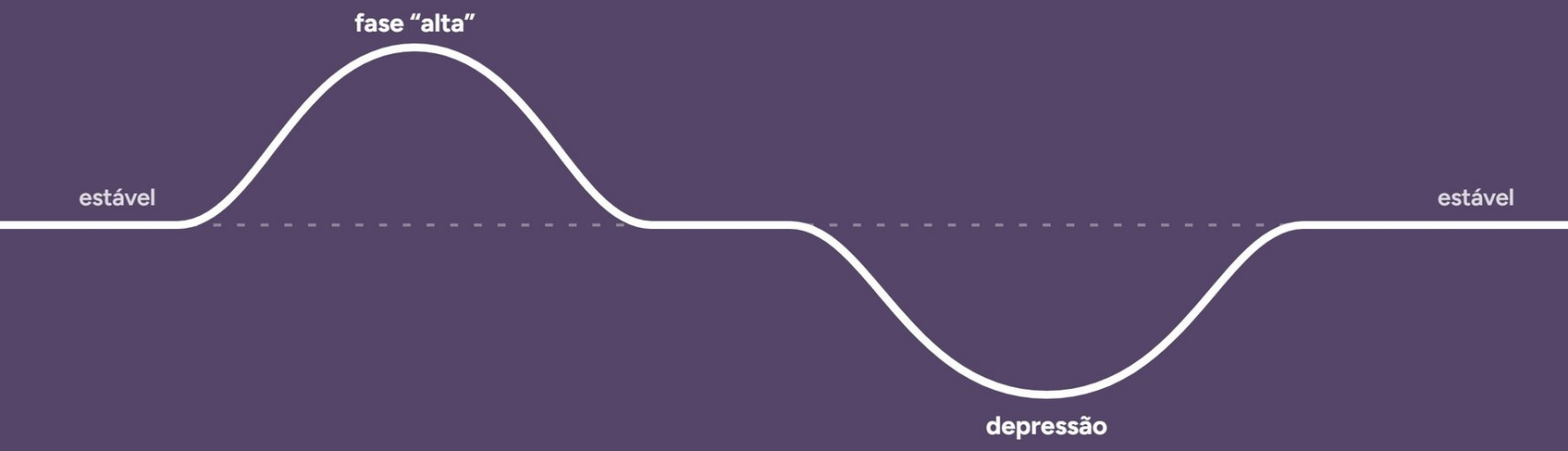
Como você é entre as crises: volta ao normal ou é sempre parecido.

CAPÍTULO

01

Transtorno Bipolar tipos 1 e 2

Episódios com começo e fim, que duram dias ou semanas, em que humor, energia e sono mudam juntos.



NESTE CAPÍTULO

1.1 Como as fases costumam aparecer: mania, hipomania e depressão

1.2 Tipo 1 e Tipo 2: nomes que você pode ouvir

1.3 Coisas que vale contar, mesmo parecendo pequenas

1.4 Para observar e contar ao médico

1.1 · COMO AS FASES COSTUMAM APARECER

Períodos com começo e fim

No Transtorno Bipolar, é comum haver episódios: períodos que duram dias ou semanas, em que humor, energia e sono mudam juntos e você fica diferente do seu jeito habitual. Entre um episódio e outro, muita gente volta a funcionar de forma próxima ao normal.

Mania FASE "ALTA" INTENSA

Anote quanto durou

Intensa a ponto de causar prejuízos sérios no trabalho, nas finanças ou nas relações. Sinais comuns:

- Euforia ou irritação muito acima do seu normal, com energia aumentada
- Pensamentos acelerados, falar muito e rápido, pular de assunto
- Gastos, sexo, direção ou investimentos de risco fora do seu padrão
- Dormir 3 ou 4 horas e não sentir cansaço
- Sensação de ser especial, invencível ou ter uma missão
- Em alguns casos, perda de contato com a realidade

Hipomania FASE "ALTA" MAIS LEVE

Anote quanto durou

Os mesmos sinais em versão mais leve. Outras pessoas notam a diferença, mas a vida não desmorona.

Atenção: muita gente vive a hipomania como "minha melhor fase" e nunca conta ao médico. Por isso, vale contar também as fases boas demais, não só as difíceis.

Depressão FASE "BAIXA"

Anote quanto durou

Tristeza ou vazio e perda de interesse, com alterações de sono, apetite, energia, concentração, culpa excessiva ou pensamentos de morte. Muitas vezes é a fase que leva a pessoa a procurar ajuda.

1.2 · TIPO 1 E TIPO 2

Nomes que você pode ouvir

"Tipo 1" e "Tipo 2" são formas que os profissionais usam para descrever padrões diferentes de fases. Chegar a isso leva tempo e acompanhamento, e não depende de um único detalhe. A sua parte é anotar bem cada fase "alta" que reconhecer:

Quanto tempo durou

Do dia em que começou até voltar ao seu normal.

Como estava o sono

Quantas horas dormia e se sentia cansaço ou não.

O que fez de diferente

Gastos, projetos, falar muito, riscos fora do seu padrão.

Quem percebeu

Alguém comentou que você estava diferente?

O que isso causou

No trabalho, no dinheiro, nas relações. Ou se nada mudou.

Como veio depois

Voltou ao normal ou veio uma fase "baixa" em seguida?

Anote em: "O que estou sentindo" (p. 23), assim que perceber a fase, e "Minha semana" (p. 20), dia a dia.

1.3 · Coisas que vale contar, mesmo parecendo pequenas

- [ ] Fases em que você precisava de muito pouco sono e se sentia ótimo
- [ ] Depressões que começaram cedo e voltaram várias vezes
- [ ] Mudanças de humor ligadas às estações do ano
- [ ] Antidepressivo que deixou você agitado, acelerado ou sem dormir
- [ ] Parentes com bipolaridade, internações psiquiátricas ou suicídio

1.4 · Para observar e contar ao médico

?

Já tive dias seguidos em que me senti "ligado" sem motivo, dormindo pouco?

?

Quanto tempo isso durou? Alguém comentou que eu estava diferente?

?

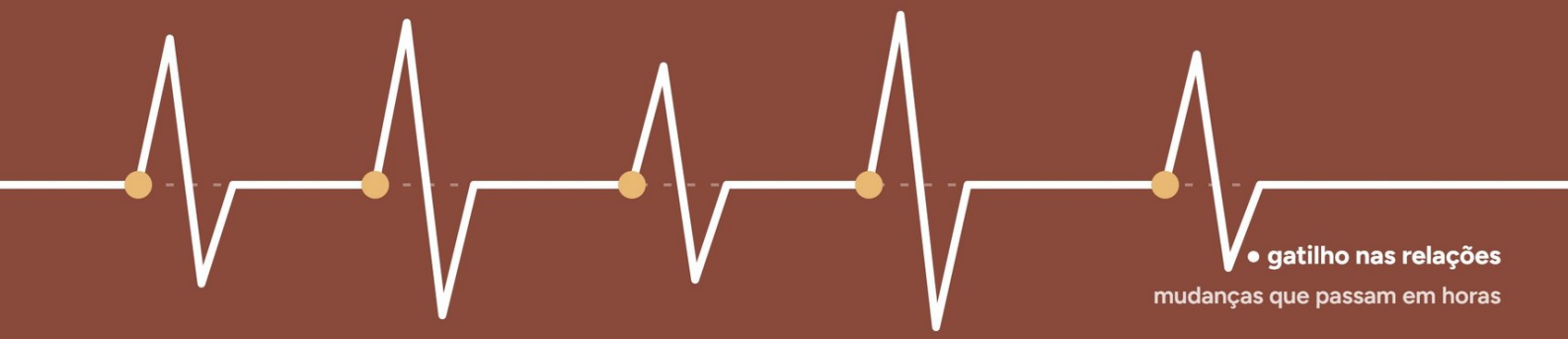
Fiz algo nesse período que normalmente não faria?

CAPÍTULO

02

Transtorno de Personalidade Borderline

A instabilidade costuma fazer parte do dia a dia, com mudanças de humor rápidas, muitas vezes ligadas às relações.



NESTE CAPÍTULO

2.1 Padrões mais comuns

2.2 Por que se confunde com o Bipolar

2.3 Para observar e contar ao médico

2.1 · PADRÕES MAIS COMUNS

Um padrão constante, não episódios

No Borderline, a instabilidade está presente desde o início da vida adulta. As mudanças de humor duram horas e costumam ser disparadas por algo nas relações:

- Uma mensagem sem resposta
- Uma crítica
- A sensação de rejeição

01

Medo de abandono

Medo intenso de ser abandonado, com esforços desesperados para evitar que isso aconteça.

02

Relações intensas

Que alternam entre idealizar e desvalorizar a mesma pessoa.

03

Identidade instável

Não saber direito quem você é, o que quer, do que gosta.

04

Impulsividade

Em áreas que podem trazer prejuízo: gastos, sexo, comida, substâncias, direção.

05

Autolesão

Comportamentos de autolesão, ameaças ou tentativas de suicídio.

06

Reações rápidas

Reações emocionais muito intensas e rápidas, que passam em horas.

07

Vazio crônico

Sensação crônica de vazio.

08

Raiva intensa

Raiva intensa, difícil de controlar.

09

Sob forte estresse

Sensação de irrealidade ou desconfiança passageira.

188 Se o item 05 faz parte do seu momento agora, ligue para o CVV (gratuito, 24 horas) ou acesse cvv.org.br.

2.2 · POR QUE SE CONFUNDE COM O BIPOLAR

Borderline e Bipolar se confundem

Nos dois, o humor muda bastante, e por fora as mudanças podem parecer iguais. O que ajuda a entender o seu caso são os detalhes de cada mudança, e não o nome que você dá a ela.



Os dois quadros podem existir ao mesmo tempo

Por isso, não tente escolher entre eles: descreva os detalhes e deixe a avaliação com o médico.

2.3 · Para observar e contar ao médico

1. Quando meu humor muda, quanto tempo leva para voltar ao normal?
2. O que aconteceu imediatamente antes?
3. Como ficaram meu sono e minha energia nesses dias?
4. Esse jeito de reagir existe desde a adolescência ou começou em uma fase específica?

Anote em: "O que estou sentindo" (p. 23), uma linha a cada mudança forte de humor.

CAPÍTULO

03

TDAH em adultos

Um transtorno do neurodesenvolvimento: os sinais começam na infância e acompanham a pessoa ao longo da vida. Ele não vem em fases.

dificuldades presentes quase todos os dias, há anos

as exigências da vida aumentam

infância

vida adulta

NESTE CAPÍTULO

3.1 Desatenção

3.2 Hiperatividade e impulsividade

3.3 Por que se confunde com Bipolar e Borderline

3.4 O que levar para a consulta

3.1 – 3.2 · OS SINAIS

Desatenção, hiperatividade e impulsividade

O que muda ao longo da vida é o quanto as exigências deixam as dificuldades aparentes. Muitos adultos só descobrem quando o trabalho ou os filhos aumentam a carga.

☐ **Marque o que é frequente e leve à consulta**

3.1 · Desatenção

- ☐ Erros por descuido em tarefas detalhadas
- ☐ Dificuldade de manter o foco em reuniões, leituras longas ou conversas
- ☐ Parecer não ouvir quando falam diretamente com você
- ☐ Começar tarefas e não terminar
- ☐ Dificuldade de organizar tempo, prazos e prioridades
- ☐ Adiar tudo o que exige esforço mental prolongado
- ☐ Perder chaves, celular, documentos com frequência
- ☐ Distrair-se com qualquer estímulo ou pensamento
- ☐ Esquecer compromissos, contas e recados

3.2 · Hiperatividade e impulsividade

- ☐ Mexer mãos e pés, inquietação física ou interna
- ☐ Dificuldade de ficar sentado por muito tempo
- ☐ Sensação de estar sempre "ligado no 220"
- ☐ Falar demais, interromper, completar a frase dos outros
- ☐ Dificuldade de esperar a vez
- ☐ Decisões rápidas sem pensar nas consequências

Lembrete

Vale lembrar como você era na infância e na escola. Boletins e o relato da família ajudam a contar isso.

3.3 · POR QUE SE CONFUNDE COM BIPOLAR E BORDERLINE

O que vale observar

FREQUÊNCIA

As dificuldades aparecem quase todos os dias ou vêm em fases?

INÍCIO

Desde quando você percebe isso? Boletins e comentários de professores ajudam a lembrar.

EMOÇÃO

Quando você se irrita ou se frustra, o que costuma estar por trás: tédio, sobrecarga, medo de ser deixado?

SONO

Quando dorme pouco, você sente cansaço no dia seguinte ou fica cheio de energia?



Os quadros podem aparecer juntos

Por isso, conte tudo o que observar, mesmo o que parecer de outro quadro.

3.4 · O que levar para a consulta

- Boletins escolares antigos ou comentários de professores
- O relato de um familiar sobre como você era na infância
- Exemplos concretos de prejuízo: atrasos, multas, contas esquecidas, demissões

CAPÍTULO 04

Detalhes que vale a pena observar

Este guia é uma ponte, não um roteiro. Cada profissional conduz a consulta do seu jeito: pode perguntar outras coisas, em outra ordem, ou seguir por outro caminho. Estas perguntas são para você fazer a si mesmo e anotar, para não depender da memória na hora. O que usar delas, e como, quem decide é o profissional.

1

DURAÇÃO

Quanto tempo durou?

Horas, dias ou semanas. Anotar na hora evita depender da memória depois.

ANOTE EM
O que estou sentindo
p. 23

2

GATILHO

Aconteceu algo antes?

Uma briga, uma mensagem sem resposta, ou nada aparente. Tudo é informação.

ANOTE EM
O que estou sentindo
p. 23

3

SONO E ENERGIA

Como ficaram meu sono e minha energia?

Dormir pouco sem cansaço é bem diferente de dormir mal e acordar exausto.

ANOTE EM
Minha semana
p. 20

4

INÍCIO

Desde quando sou assim?

Desde a infância, desde a adolescência ou a partir de uma fase específica.

ANOTE EM
Ficha da primeira consulta
p. 22

5

ENTRE AS CRISES

Como fico entre uma crise e outra?

Volto ao meu jeito de sempre ou as dificuldades continuam?

ANOTE EM
Minha semana
p. 20

6

HISTÓRICO

Que remédios já usei? Alguém na família tem diagnóstico?

Como você reagiu a cada remédio e o histórico da família são informações valiosas.

ANOTE EM
Ficha da primeira consulta
p. 22

Este guia não serve para se diagnosticar

Os quadros podem aparecer juntos, e outras causas (tireoide, sono, substâncias) dão sinais parecidos. Só a avaliação de um profissional separa uma coisa da outra.

4.2 · FATOS, NÃO RÓTULOS

Leve o que aconteceu, não o palpite

É natural chegar com uma suspeita depois de ler sobre o assunto, e você pode contá-la. Mas o que mais ajuda na conversa são os fatos por trás dela.

EM VEZ DE SÓ O RÓTULO	LEVE O FATO
"Acho que sou bipolar."	Em março tive 5 dias dormindo 4 horas por noite, sem cansaço, e gastei R$ 3 mil sem planejar. Minha irmã disse que eu estava diferente.
"Acho que tenho TDAH."	Desde a escola perco prazos e objetos quase todo dia. Tenho boletins com comentários dos professores sobre isso.
"Acho que sou borderline."	Quando alguém demora a responder, entro em desespero em minutos. Passa em algumas horas e acontece toda semana.

O que também pode ajudar na consulta

Alguém próximo

Quem convive com você percebe mudanças que você não nota. Leve essa pessoa ou o que ela observou.

Documentos

Boletins antigos, receitas e laudos de outros médicos, se tiver.

Remédios

Os que já usou, a dose e o que você sentiu com cada um.

Se reconheceu sinais de mais de um quadro, conte todos

Eles podem existir ao mesmo tempo. Separar o que é cada coisa é parte da avaliação, não uma tarefa sua.

Use com as ferramentas: o humor de cada dia você pinta em "Minha semana" (p. 20). Quanto durou e o que disparou, você anota em "O que estou sentindo" (p. 23). A história desde a infância vai na "Ficha da primeira consulta" (p. 22).

CAPÍTULO 05

Como relatar ao psiquiatra

Um bom relato troca adjetivos por fatos: quanto tempo, quantas vezes, o que aconteceu antes e o que mudou na sua vida. Você não precisa usar termos técnicos. Precisa de exemplos.

A fórmula do relato preciso

O que aconteceu + **Quanto tempo** durou + **O que disparou** logo antes + **O que mudou** sono, trabalho, relações, dinheiro + **Desde quando** isso acontece

Frases vagas x frases precisas

EM VEZ DE DIZER	TENTE DIZER
✕ "Meu humor oscila muito."	✓ "Em março, passei 10 dias dormindo 4 horas por noite, sem cansaço, falando sem parar. Depois, fiquei 3 semanas sem conseguir sair da cama."
✕ "Sou muito explosivo."	✓ "Quando sinto que alguém vai me deixar, fico com muita raiva em minutos. Passa em algumas horas e depois sinto culpa."
✕ "Não consigo me concentrar."	✓ "Desde a escola, perco o foco em leituras após 5 minutos. No trabalho, já perdi 3 prazos este ano."
✕ "Às vezes fico muito bem."	✓ "Algumas vezes por ano tenho 4 ou 5 dias de energia enorme, durmo pouco e começo vários projetos. Minha família diz que fico diferente."
✕ "Sou impulsivo."	✓ "No mês passado, gastei R$ 3.000 em um fim de semana sem planejar. Isso já aconteceu outras vezes."

5.2 · DICAS PARA A CONSULTA

No dia da consulta

Sete atitudes simples para você contar o quadro completo.

1 Conte também as fases boas

A hipomania é a informação mais esquecida. Fases de muita energia e pouco sono também precisam entrar no relato.

2 Leve a página da consulta

"Para levar à consulta" (p. 21), junto com as folhas da semana.

3 Diga como reagiu a remédios

Os que já tomou, inclusive antidepressivos.

4 Fale sobre álcool e substâncias

Sem medo de julgamento.

5 Leve alguém, se possível

Uma pessoa que conviva com você.

6 Seja honesto sobre pensamentos de morte ou autolesão

Isso muda o cuidado que você recebe.

7 · TERMINE COM ESTA PERGUNTA

"O que mais o senhor (ou a senhora) precisa saber para avaliar melhor?"

USE · FERRAMENTAS PARA IMPRIMIR

Essenciais e extra

As folhas estão nas próximas páginas, prontas para imprimir em alta qualidade: imprima direto deste PDF, quantas vezes precisar. Só 3 são essenciais; a quarta é extra.

ESSENCIAL

Ficha da primeira consulta	1 VEZ	5 min	Antes da primeira consulta	p. 22
Minha semana	TODO DIA	20 s	Até o diagnóstico	p. 20
Para levar à consulta	NA VÉSPERA	5 min	A cada consulta	p. 21

EXTRA · USE SE FIZER SENTIDO

O que estou sentindo	QUANDO ACONTECER	1 min	Para não esquecer	p. 23

Imprima 1 “Ficha”, 4 “Minha semana” por mês e 1 “Para levar à consulta” para cada consulta. Deixe ao lado da cama, com uma caneta.

USE · ESSENCIAL **TODO DIA** 20 segundos — Para: todos

Minha semana

Todo dia, pinte **1 bolinha no sono** e **1 no humor**. **Dia difícil?** Só o humor, ou deixe em branco. **Alguém próximo pode pintar por você.**

Semana de ___/___	Seg __/__	Ter __/__	Qua __/__	Qui __/__	Sex __/__	Sáb __/__	Dom __/__
SONO quanto dormi esta noite							
10 h ou mais	○	○	○	○	○	○	○
9 h	○	○	○	○	○	○	○
8 h	○	○	○	○	○	○	○
7 h	○	○	○	○	○	○	○
6 h	○	○	○	○	○	○	○
5 h	○	○	○	○	○	○	○
4 h ou menos	○	○	○	○	○	○	○
HUMOR como estive na maior parte do dia							
Fora do controle	○	○	○	○	○	○	○
Acelerado, cheio de planos	○	○	○	○	○	○	○
Animado	○	○	○	○	○	○	○
Normal para mim	○	○	○	○	○	○	○
Pra baixo	○	○	○	○	○	○	○
Pesado, tudo custa	○	○	○	○	○	○	○
Não consegui sair da cama	○	○	○	○	○	○	○
REMÉDIO se você usa							
Tomei como combinado	○	○	○	○	○	○	○
Senti efeito colateral	○	○	○	○	○	○	○
SE ACONTECEU pinte só o que for verdade hoje							
Pensamentos acelerados	○	○	○	○	○	○	○
Muito irritado	○	○	○	○	○	○	○
Briga ou me senti rejeitado	○	○	○	○	○	○	○
Bebi ou gastei além da conta	○	○	○	○	○	○	○
Perdi o foco ou esqueci algo	○	○	○	○	○	○	○

Domingo · 1 minuto

Conte as bolinhas e escreva só o número

- ☐ **Noites com 5 h ou menos** — 2 últimas linhas do sono
- ☐ **Dias acelerados** — 2 primeiras linhas do humor
- ☐ **Dias muito para baixo** — 2 últimas linhas do humor

Pergunte a alguém próximo: "Eu estive diferente do normal esta semana?" ○ **não** ○ **um pouco** ○ **muito**

3 noites ou mais com 5 h ou menos, ou resposta "muito"? Avise seu médico antes da próxima consulta. Pensamentos de morte: ligue 188 (CVV).

USE · ESSENCIAL **NA VÉSPERA** 5 minutos · entregue ao médico Para: todos

Para levar à consulta

Nome _____

Consulta de ___/___/_____ · Última consulta foi em ___/___/_____

1 Minhas últimas semanas

COPIE DO DOMINGO DA MINHA SEMANA

Semana de	Noites com 5 h ou menos	Dias acelerados	Dias muito para baixo	Alguém notou diferença?
___/___				não · pouco · muito
___/___				não · pouco · muito
___/___				não · pouco · muito
___/___				não · pouco · muito

2 Desde a última consulta

Primeira consulta? Compare com 2 meses atrás.

Humor	○ melhorou	○ igual	○ piorou
Sono	○ melhorou	○ igual	○ piorou
Energia e foco	○ melhorou	○ igual	○ piorou
Relações	○ melhorou	○ igual	○ piorou
Trabalho ou estudo	○ melhorou	○ igual	○ piorou

3 Remédios

Tomei como combinado:

○ sempre ○ quase sempre ○ esqueci várias vezes

Efeitos que senti:

○ sono ○ sonolência ○ apetite ou peso ○ tremor ○ libido ○ nenhum

Outro: _____

4 O que mais quero contar

COPIE AS LINHAS MARCADAS EM "O QUE ESTOU SENTINDO"

1 _____

2 _____

3 _____

5 Minha pergunta de hoje

_____

_____

6 Pensamentos de morte ou de me machucar

○ nunca ○ já tive ○ tenho agora

Se "agora", fale disso logo no começo.

Não deu tempo de copiar? Leve as folhas como estão. O que importa é ir à consulta.

Para o profissional: resumo das últimas semanas, feito pelo paciente (ou por alguém próximo) a partir de registros diários (Minha semana: sono em horas e humor em 7 níveis descritos em palavras) e de anotações de eventos (O que estou sentindo). Sem interpretação. Material educativo, não diagnóstico.

USE · ESSENCIAL **1 VEZ** antes da primeira consulta · 5 min **Para: quem ainda não tem diagnóstico**

Ficha da primeira consulta

Nome _____

Uma vez só. Não é teste e não tem pontuação. São informações que costumam ajudar na primeira consulta. Se você já está em tratamento, não precisa desta folha.

1 O que me trouxe à consulta

_____

_____

_____

2 Minha história

MARQUE UMA OPÇÃO

Já passei semanas seguidas sem vontade de nada, quase todo dia	○ sim ○ não ○ não sei
Já tive vários dias seguidos dormindo pouco e me sentindo cheio de energia	○ sim ○ não ○ não sei
Algum antidepressivo já me deixou agitado ou sem dormir	○ sim ○ não ○ não sei
Na escola, diziam que eu era distraído ou agitado	○ sim ○ não ○ não sei
A distração acontece em casa e no trabalho ou estudo, não só numa fase	○ sim ○ não ○ não sei
Meu humor muda em poucas horas depois de brigas ou rejeição	○ sim ○ não ○ não sei
Alguém da família teve bipolaridade, depressão, vício ou suicídio	○ sim ○ não ○ não sei

Isso começou por volta dos _____ anos Quem pode pintar por mim num dia difícil _____

3 Tratamentos que já fiz

REMÉDIOS E TERAPIAS

Remédio ou terapia	Por quanto tempo	Como foi
		ajudou · acelerou · fez mal
		ajudou · acelerou · fez mal
		ajudou · acelerou · fez mal
		ajudou · acelerou · fez mal

Leve também, se tiver

- Boletins ou comentários de professores
- O relato de alguém que conviva com você
- Receitas e exames antigos

4 Pensamentos de morte ou de me machucar

○ nunca ○ já tive ○ tenho agora

Se "agora", fale disso logo no começo.

USE · EXTRA **QUANDO ACONTECER** 1 minuto — Para: todos

O que estou sentindo

Nome _____

Aconteceu algo que você quer contar ao médico? Anote na hora, numa linha. Não precisa de frase bonita: só fatos.

o que senti · **+ quanto durou** · **+ o que veio antes** · **+ o que mudou no dia**

Data	O que senti ou aconteceu	Quanto durou	O que veio antes	O que mudou no dia	Contar
exemplo 12/03	*Raiva muito forte, chorei e quis largar tudo*	*umas 3 horas*	*Crítica do chefe na reunião*	*Não consegui trabalhar à tarde*	★
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐
					☐

Na véspera: marque “Contar” nas 3 linhas mais importantes e copie para “Para levar à consulta”. Assim nada fica esquecido.

Pensamentos de morte ou de se machucar: não espere a consulta. Ligue 188 (CVV) ou, em emergência, 192.

DEPOIS DO DIAGNÓSTICO

Recebeu um diagnóstico? *Conte pra gente o que faltou.*

Este guia é para o caminho até o diagnóstico. Depois dele, começa outra fase: acompanhar o tratamento e contar, a cada retorno, como foram as semanas. Ainda não sabemos qual ferramenta ajuda mais nessa fase. Antes de criar qualquer coisa, estamos testando estas folhas em papel com quem usa.

1

Continue com as folhas

"Minha semana" e "Para levar à consulta" também servem entre um retorno e outro. Imprima quantas vezes precisar.

2

Conte como foi

Usou as folhas? Levou à consulta? Ajudou? São 3 perguntas, 1 minuto, sem precisar deixar e-mail.

3

Ajude a decidir o próximo passo

O que ajudou e o que faltou decide a versão 2 do Mapa e se vale criar uma ferramenta para depois do diagnóstico.

VERSÃO 1 · EM TESTE COM QUEM USA

Sua resposta decide a versão 2

Conte como foi usar o guia e as folhas. Não precisa contar nada sobre sua saúde que não queira.

Responda em

draxora.com.br/conte

O Mapa dos Sintomas não faz diagnóstico e não substitui o acompanhamento profissional. Em crise, ligue 188 (CVV) ou 192 (SAMU).

FECHAMENTO

Você não precisa ter certeza, só precisa ser claro

Diagnóstico é trabalho do profissional. O seu papel é levar informação boa. Com as folhas, você chega a cada consulta com semanas de registro organizadas em uma página. Assim, a conversa parte de fatos, e não só do que você consegue lembrar no dia.

Se a primeira consulta não esclarecer tudo, é normal. Alguns diagnósticos precisam de mais de um encontro e de acompanhamento ao longo do tempo. Buscar uma segunda opinião também é um direito seu.

ONDE BUSCAR AJUDA

188
CVV
Gratuito, 24 horas, ou cvv.org.br

192
Emergência
SAMU ou pronto-socorro mais próximo

SUS
UBS do seu bairro
Pode encaminhar para um CAPS

Baixo custo
Clínicas-escola
De psicologia e ambulatórios de universidades

REFERÊNCIAS

American Psychiatric Association. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5-TR). Porto Alegre: Artmed, 2023.

Organização Mundial da Saúde. CID-11: Classificação Internacional de Doenças, capítulo de transtornos mentais.

Associação Brasileira de Psiquiatria (abp.org.br) e Associação Brasileira do Déficit de Atenção (tdah.org.br).

AUTORIA

Elias Jr · Draxora

REVISÃO DE CONTEÚDO

Tatiane Moraes Araujo · Psicóloga, CRP 20/05360